Antibióticos - parte 1

Doses basais com função renal preservada, salvo indicação expressa. A indicação, a via e o esquema-base definem o ajuste.

Prévia educacional • revisão médica humana pendente. Não usar tabelas de DRC como dose automática em HD, CRRT ou lesão renal aguda.

MEDICAMENTO / FONTES	DOSE ADULTA DE REFERÊNCIA	AJUSTE RENAL / PONTO DE ATENÇÃO
Ceftriaxona Fontes: [1] [2]	2 g IV a cada 24 h. Meningite: 2 g IV a cada 12 h.	Sem ajuste renal isolado ou por HD. Se disfunção renal E hepática graves: individualizar; não exceder 2 g/dia sem avaliação adicional. CRRT: avaliar contexto. **Atenção:** Não misturar com cálcio IV na mesma linha; vigiar bile/INR. Não cobre Pseudomonas.
Cefepima Fontes: [1] [2]	Infecção grave: 2 g IV a cada 8 h (esquema-base). Infusão prolongada: protocolo próprio.	ClCr (mL/min): >60: 2 g a cada 8 h; 30-60: 2 g a cada 12 h; 10-29: 2 g a cada 24 h; <10: 1 g a cada 24 h. HD/CRRT: regimes próprios. **Atenção:** Monitorar rim e estado mental; confusão/mioclonia podem indicar neurotoxicidade.
Piperacilina-tazobactam Fontes: [1] [2]	3,375 g IV a cada 6 h. Pneumonia hospitalar (PH): 4,5 g a cada 6 h. Infusão de 30 min. 4,5 g = 4 g + 0,5 g.	ClCr >40 mL/min: sem redução; 20-40: 2,25 g a cada 6 h (PH: 3,375 g a cada 6 h); <20: 2,25 g a cada 8 h (PH: a cada 6 h). Tabela SÓ para infusão de 30 min. HD/CRRT: tabela própria. **Atenção:** Não aplicar à infusão prolongada. Com vancomicina: maior risco renal; vigiar K.
Meropenem Fontes: [1] [2]	Habitual: 1 g IV a cada 8 h. Meningite: 2 g a cada 8 h. Infusão otimizada de 3 h: protocolo próprio.	Base 1 g, ClCr (mL/min): >50: a cada 8 h; 26-50: 1 g a cada 12 h; 10-25: 500 mg a cada 12 h; <10: 500 mg a cada 24 h. Base 2 g: doses duplicadas. HD/CRRT: esquema por foco/modalidade. **Atenção:** Evitar valproato/divalproato; vigiar rim e convulsões. Não cobre MRSA.
Oxacilina Fontes: [1] [2]	MSSA grave: 2 g IV a cada 4 h (regime institucional).	Sem tabela universal por ClCr. Em disfunção renal importante, sobretudo com hepatopatia, individualizar por exposição/toxicidade. HD/CRRT: validar protocolo específico. **Atenção:** MSSA, não MRSA. Monitorar rim, K, fígado/hemograma e carga de sódio.
Cefazolina Fontes: [1]	Infecção complicada/MSSA: 2 g IV a cada 8 h.	ClCr (mL/min): >30: 2 g a cada 8 h; 10-29: 2 g a cada 12 h; <10: 1 g a cada 24 h. Exatamente 30: limite não coberto pela tabela UCSF; confirmar protocolo/farmácia. HD/CRRT: esquemas próprios. **Atenção:** Não cobre MRSA/Pseudomonas; vigiar rim, estado mental e INR se risco.
Ampicilina-sulbactam Fontes: [1] [2]	CONVENCIONAL: 3 g IV a cada 6 h = 2 g de ampicilina + 1 g de sulbactam por dose.	Convencional, ClCr (mL/min): >30: 3 g a cada 6 h; 15-30: 3 g a cada 12 h; <15: 3 g a cada 24 h. HD/CRRT: tabela própria. Não extrapolar para alta dose de sulbactam. **Atenção:** CRAB/alta dose não está nesta tabela: consultar guia completo. Vigiar rim, Na/K e fígado.
Metronidazol Fontes: [1] [2]	500 mg IV/VO a cada 8 h. Foco intra-abdominal selecionado: 500 mg a cada 12 h (UCSF).	ClCr <10 mL/min: 500 mg a cada 12 h (UCSF). HD: programar após sessão; eventual reposição depende do horário. CRRT: protocolo próprio. Hepatopatia grave: individualizar/reduzir. **Atenção:** Varfarina: INR; lítio: toxicidade. Evitar duplicação anaeróbia; vigiar neurotoxicidade.

ClCr em mL/min, salvo unidade indicada na linha. Dose em mg/kg: conferir peso de cálculo/obesidade. TDM = níveis séricos; AUC = exposição em 24 h.

Ferramenta educacional/de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico, os protocolos institucionais ou a avaliação médica individual.

Antibióticos - parte 2

Doses basais com função renal preservada, salvo indicação expressa. A indicação, a via e o esquema-base definem o ajuste.

Prévia educacional • revisão médica humana pendente. Não usar tabelas de DRC como dose automática em HD, CRRT ou lesão renal aguda.

MEDICAMENTO / FONTES	DOSE ADULTA DE REFERÊNCIA	AJUSTE RENAL / PONTO DE ATENÇÃO
Vancomicina IV Fontes: [1] [2]	Crítico: ataque 20-35 mg/kg de peso real IV, máx. 3 g. Manutenção inicial, rim normal: 15-20 mg/kg a cada 8-12 h; ajustar por AUC.	Sem tabela fixa de manutenção por ClCr isolada. MRSA invasivo: alvo AUC24 400-600 mg.h/L se CIM presumida 1 mg/L. Recalcular com níveis/rim; HD e CRRT exigem regimes próprios. **Atenção:** AUC/TDM + creatinina/diurese. Infundir lentamente; maior risco com outros nefrotóxicos.
Linezolida Fontes: [1] [2]	600 mg IV/VO a cada 12 h. Infusão IV em 30-120 min.	Sem redução renal de bula. HD: após sessão quando coincidir. Maior risco de trombocitopenia na disfunção renal; TDM/ajuste especializado no uso prolongado, sem redução empírica automática. **Atenção:** Hemograma/plaquetas; serotoninérgicos: vigiar clônus, agitação e hipertermia. Não cobre G-.
Daptomicina Fontes: [1] [2]	Infecção invasiva: 8-10 mg/kg IV a cada 24 h (UCSF). Peso ajustado se >120% do ideal, conforme protocolo.	ClCr >=30 mL/min: a cada 24 h; <30: mesma dose a cada 48 h. HD/CRRT: esquemas próprios por sessão/fluxo; não transportar o intervalo da HD para CRRT. **Atenção:** NÃO trata pneumonia. CPK basal/semanal; estatinas aumentam risco de miopatia.
Sulfametoxazol-trimetoprima (TMP-SMX) Fontes: [1] [2]	Dose em TMP: pneumocistose 15 mg/kg/DIA; infecção sistêmica G- sensível 10 mg/kg/DIA, IV/VO divididos a cada 8-12 h (UCSF).	ClCr 15-30 mL/min: metade da dose diária acima, dividida a cada 12-24 h (UCSF). <15: pneumocistose TMP 5 mg/kg a cada 24 h; sistêmica TMP 2,5 mg/kg a cada 24 h (UCSF). HD/CRRT: usar tabela própria; não extrapolar. **Atenção:** Dose em TMP/DIA, não por tomada. Monitorar K/hemograma; IECA/BRA, varfarina e metotrexato.
Clindamicina Fontes: [1] [2]	Necrosante/estreptococo A: 900 mg IV a cada 8 h, como adjuvante. Outras selecionadas: 600 mg IV a cada 8 h.	Não requer ajuste renal ou por HD. Hepatopatia grave/uso prolongado: individualizar e monitorar fígado; CRRT não exige redução renal rotineira. **Atenção:** Não substitui cirurgia/betalactâmico; vigiar C. difficile. Potencializa bloqueio neuromuscular.
Azitromicina Fontes: [1] [2]	Pneumonia comunitária na UTI: 500 mg IV/VO a cada 24 h, geralmente com betalactâmico. IV: nunca em bolus; respeitar bula.	Sem ajuste renal rotineiro ou por HD/CRRT. Disfunção renal extrema/hepatopatia: avaliação individual e monitorização. **Atenção:** QTc/K/Mg; evitar múltiplos prolongadores de QT. Revisar digoxina e varfarina.
Levofloxacino Fontes: [1] [2]	Esquema-base: 750 mg IV/VO a cada 24 h. IV 750 mg em pelo menos 90 min.	ClCr (mL/min): >=50: 750 mg a cada 24 h; 20-49: 750 mg a cada 48 h; <20 ou HD: 750 mg inicial, depois 500 mg a cada 48 h. CRRT: tabela própria. Não aplicar ao esquema-base de 500 mg. **Atenção:** QT/glicemia; AINE: SNC, corticoide: tendão, varfarina: INR. VO: separar de cátions >=2 h.
Ceftazidima-avibactam Fontes: [1] [2]	2,5 g IV (2 g + 0,5 g) a cada 8 h em 3 h: exposição otimizada IDSA, que pode diferir da bula local.	ClCr (mL/min): >50: 2,5 g a cada 8 h; 31-50: 1,25 g a cada 8 h; 16-30: 0,94 g a cada 12 h; 6-15: 0,94 g a cada 24 h; <=5: 0,94 g a cada 48 h. HD/CRRT: regimes próprios. Reajustar se rim melhorar. **Atenção:** KPC/OXA-48 sensíveis; MBL não coberta isoladamente. Vigiar rim, SNC e culturas.

ClCr em mL/min, salvo unidade indicada na linha. Dose em mg/kg: conferir peso de cálculo/obesidade. TDM = níveis séricos; AUC = exposição em 24 h.

Ferramenta educacional/de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico, os protocolos institucionais ou a avaliação médica individual.

Antifúngicos - esquemas selecionados

Doses basais com função renal preservada, salvo indicação expressa. A indicação, a via e o esquema-base definem o ajuste.

Prévia educacional • revisão médica humana pendente. Não usar tabelas de DRC como dose automática em HD, CRRT ou lesão renal aguda.

MEDICAMENTO / FONTES	DOSE ADULTA DE REFERÊNCIA	AJUSTE RENAL / PONTO DE ATENÇÃO
Fluconazol IV/VO Fontes: [1] [2] [3]	Candidemia suscetível: ataque 800 mg (12 mg/kg) uma vez; depois 400 mg (6 mg/kg) a cada 24 h.	ClCr mL/min: >50, manutenção integral; ≤50 sem HD, 50% da manutenção. Ataque integral. HD: dose integral após sessão; dias sem HD, ajustar à função residual. CRRT: dose individual por modalidade/efluente; ver guia completo. **Atenção:** Choque/alto risco de azol-R: equinocandina inicial. Não cobre Aspergillus/Mucorales. Rever QT, hepatograma e interações CYP.
Anidulafungina IV Fontes: [1]	Candidemia/invasiva: ataque 200 mg no dia 1; depois 100 mg a cada 24 h. Infundir 200 mg em ≥180 min; 100 mg em ≥90 min.	Sem ajuste renal ou HD; sem suplemento pós-HD. CRRT: geralmente dose usual; rever exposição se peso/MIC/foco especiais. **Atenção:** Baixa exposição em urina/SNC/olho. ERAXIS contém frutose: contraindicado na intolerância hereditária à frutose. Vigiar fígado e infusão.
Caspofungina IV Fontes: [1]	Candidemia/invasiva: ataque 70 mg no dia 1; depois 50 mg a cada 24 h, em cerca de 1 h. Rifampicina: manutenção 70 mg/dia segundo bula.	Sem ajuste renal/HD; sem suplemento pós-HD. CRRT: geralmente sem redução; não confundir ajuste renal com ajuste hepático. **Atenção:** Não diluir em glicose. Child-Pugh 7-9: bula usa 35 mg/dia na manutenção, ataque 70 mg; validar aplicação no crítico sem cirrose.
Anfotericina B LIPOSSOMAL IV Fontes: [1] [2] [3]	Candida invasiva: 3-5 mg/kg a cada 24 h. Mucormicose: 5-10 mg/kg/dia; SNC geralmente 10 mg/kg/dia, sob especialista.	Sem redução renal fixa ou suplemento pós-HD; CRRT habitualmente dose usual. Nefrotoxicidade exige reavaliar terapia. Documentar peso de cálculo, especialmente em obesidade. **Atenção:** Não intercambiar formulações mg por mg. AmBisome: glicose 5%, infusão usual 120 min. Monitorar creatinina, K/Mg e reação de infusão.
Voriconazol IV/VO Fontes: [1] [2]	Aspergilose: ataque 6 mg/kg IV a cada 12 h por 2 doses; depois 4 mg/kg IV a cada 12 h. VO ≥40 kg: bula usa 200 mg a cada 12 h; ajustar por resposta/TDM.	VO: sem ajuste renal. IV: evitar se ClCr <50 mL/min (SBECD), salvo benefício-risco favorável. HD: sem ajuste do ativo. CRRT: avaliar veículo/modalidade e TDM; não reduzir automaticamente o ativo. **Atenção:** Não cobre Mucorales. Rever CYP/QT e hepatograma. Child-Pugh A/B: manter ataque e reduzir manutenção à metade (bula). Peso/troca IV-VO exigem revisão.
Isavuconazol (ativo) IV/VO Fontes: [1]	Aspergilose/mucormicose: 200 mg a cada 8 h por 6 doses; depois 200 mg a cada 24 h. Brasil: 200 mg de ativo = 372,6 mg de sulfato de isavuconazônio.	Sem ajuste renal/HD; IV sem SBECD. CRRT habitualmente dose usual, com revisão de exposição e interações. **Atenção:** Manutenção 12-24 h após último ataque. IV ≥1 h. Encurta QT; contraindicado no QT curto familiar. Rever CYP3A4 e hepatograma.

ClCr em mL/min, salvo unidade indicada na linha. Dose em mg/kg: conferir peso de cálculo/obesidade. TDM = níveis séricos; AUC = exposição em 24 h.

Ferramenta educacional/de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico, os protocolos institucionais ou a avaliação médica individual.

Antivirais - tratamento selecionado

Doses basais com função renal preservada, salvo indicação expressa. A indicação, a via e o esquema-base definem o ajuste.

Prévia educacional • revisão médica humana pendente. Não usar tabelas de DRC como dose automática em HD, CRRT ou lesão renal aguda.

MEDICAMENTO / FONTES	DOSE ADULTA DE REFERÊNCIA	AJUSTE RENAL / PONTO DE ATENÇÃO
Aciclovir IV Fontes: [1] [2]	Encefalite HSV / VZV disseminado: dose-base 10 mg/kg a cada 8 h, cada dose em ≥1 h. Outros focos têm doses próprias.	ClCr INDEXADA (mL/min/1,73 m²): >50, dose-base 8/8 h; >25-50, dose-base 12/12 h; >10-25, dose-base 24/24 h; ≤10, 50% da dose-base 24/24 h. HD encefalite/VZV (UCSF): 5 mg/kg IV 24/24 h, após sessão nos dias de HD. CRRT: ver guia. **Atenção:** Hidratação conforme tolerância. Vigiar creatinina/diurese e neurotoxicidade. Obesidade: documentar peso de dose; bula/UCSF diferem.
Ganciclovir IV - INDUÇÃO Fontes: [1] [2]	Doença por CMV: indução 5 mg/kg a cada 12 h, em 1 h. Não usar esta tabela para manutenção/profilaxia.	INDUÇÃO, ClCr mL/min: ≥70, 5 mg/kg 12/12 h; 50-69, 2,5 mg/kg 12/12 h; 25-49, 2,5 mg/kg 24/24 h; 10-24, 1,25 mg/kg 24/24 h. HD convencional: 1,25 mg/kg pós-sessão, 3 vezes/semana. <10 sem HD: especialista. CRRT/outro calendário de HD: ver guia. **Atenção:** Vigiar hemograma/plaquetas, rim e CMV-DNA. Não associar maribavir; cautela com imipenem (convulsões). Documentar peso de cálculo.
Oseltamivir VO/sonda Fontes: [1]	Influenza no hospitalizado/grave: 75 mg a cada 12 h; curso usual 5 dias, duração maior conforme evolução/persistência viral.	TRATAMENTO, ClCr mL/min: >60, 75 mg 12/12 h; >30-60, 30 mg 12/12 h; >10-30, 30 mg 24/24 h. ≤10 sem diálise: não recomendado. HD: 30 mg imediatamente e após cada sessão no curso de 5 dias. CRRT: individualizar; ver guia. **Atenção:** Não aguardar confirmação para iniciar no grave suspeito. Não dobrar dose rotineiramente. Estas faixas não são de profilaxia.
Remdesivir IV Fontes: [1] [2]	Adulto ≥40 kg com COVID-19 elegível: 200 mg no dia 1; depois 100 mg a cada 24 h. Hospitalar usual 5 dias; extensão conforme resposta/bula. Infusão em 30-120 min.	Sem ajuste em qualquer grau de insuficiência renal, inclusive HD; sem vínculo obrigatório ao horário da HD. CRRT: dose usual do ativo; acompanhar resposta e função hepática. **Atenção:** IDSA desaconselha início rotineiro já em VM invasiva/ECMO. Vigiar ALT/AST e reações de infusão; evitar cloroquina/hidroxicloroquina.

ClCr em mL/min, salvo unidade indicada na linha. Dose em mg/kg: conferir peso de cálculo/obesidade. TDM = níveis séricos; AUC = exposição em 24 h.

Ferramenta educacional/de apoio à decisão. Não substitui o julgamento clínico, os protocolos institucionais ou a avaliação médica individual.